



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : فاتن حسني شوقي رمضان
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : البدرشين
رقم البطاقة : 28409122101402 رقم التليفون : 01065566150
العنوان : =
العمر (تاريخ الميلاد) : 12-09-1984 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 09-10-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- / د. / ----- / د. / ----- / د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: فاتن حسني شوقي رمضان National ID: 28409122101402	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



3-11



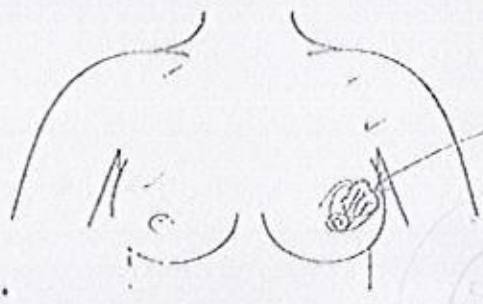
Name: P. J. in P. in 16
Age: 47
No.:

5/11/2020

MDT FORM

Clinical data:

BR 2/8
PR 6/8
PC 2 (15)
KOT 60



Of. breast
400 mm
8x5 cm

Reason of discussion:

MDT: A lump bc additional
non palpable lump present

MDT Outcome and Plan:

For further evaluation, investigation &
treatment

Signature:

Neelaj Chandra
Mastectomy + reconstruction
← to 5/11/20

Dr. J. J. in P. in 16

Name: فاتن حسني شوقي رمضان			
MR. : 551			
Detailed Medical Report			
			السيد
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
		رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient is a 41-year-old individual with a diagnosis of left-sided invasive ductal carcinoma, grade II, estrogen receptor 7/8 positive, progesterone receptor 8/8 positive, HER2-negative, and Ki-67 proliferation index 50-60 %. Neoadjuvant chemotherapy was administered consisting of four cycles of epirubicin-cyclophosphamide (4EC) followed by four cycles of docetaxel (4TXT). The patient subsequently underwent left simple mastectomy with sentinel lymph node biopsy on 15 June 2021, achieving a partial pathological response (ypT1c ypN0) with 0/3 positive nodes. Post-operative imaging showed a partial response. Current adjuvant therapy includes tamoxifen 20 mg daily, calcium 1 tablet daily, and a subcutaneous injection of Zoladex 10.8 mg (one-alpha formulation). At the follow-up visit, imaging performed on 29 March 2026 demonstrated a fatty liver and chronic calculous cholecystitis; the chest CT report was pending. The patient remains on tamoxifen and Zoladex, with the next appointment scheduled in three months. At the most recent visit, the patient continued tamoxifen; the scheduled Zoladex injection was postponed to the following month due to drug unavailability. The plan is to administer Zoladex at the next monthly visit.			
تحريراً في ,			
التاريخ :		21-09-2026	
الوقت :		إيه مدحت بدوي محمد	
الطبيب المعالج :		يعتمد ,	

????, ???? Patient ID: 10110224012189 DOB: 12-Sep-1984 Date: 02-Dec-2024
Patient Lastname: حسني
Patient Firstname: ذن
HIS Patient ID: 10110224012189
RIS Patient ID: 362777
Date of Birth: 12/09/1984

Procedure: 70030, Bone Scan
Medical Question:
Clinical Comment:

===== REPORT TEXT =====

99mTc MDP Bone Scan Report (02/12/2024)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of 99mTc MDP
Revealed:

- " No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
 - " Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
 - " Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
 - " Both kidneys are visualized.
- Conclusion:
- " No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obligated
Omnia Talaat, MD

===== REPORT TEXT ENDE =====



National Women's Health Initiative
Pathology Lab
معمل باثولوجي المبادرة القومية لصحة المرأة



Pathology Report

Name: فائق حماني شوقي

Age: 36 years.

Clinical data: left breast mass, post NAC.

Specimen type: SLNs & Lt simple mastectomy.

Date (Received): 15/6/2021.

Date(reported): 20/6/2021

Lab. Number: 1254/ 21

Hospital Number

Gross Examination:

- Procedure: excision of sentinel LN & Lt simple mastectomy.
- Localization:left
- Tumor extent
 - Number: tumor bed site area
 - Size:4.5x4cm
 - Skin involvement:no
- Distance from margins:
- Lymph nodes number and size: 3 nodules up to 1.3x1cm
- Additional pathologic findings: N/A
- Immunohistochemistry technique.N/A

Microscopic examination:

- Histological type: remnant of IDC in microscopic area (about 0.5cm)
- Grade: II



Name: RAYON HOSNEY SHAWKY

Date: 12/10/2020

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS WITH CORONAL RECONSTRUCTION: -

Reading was done from external films with no available thin cuts or bone window which degraded the quality of the study.

Known case of MM as reported in radiology request.

No available CT brain films

Chest:

- Few lingular thin atelectatic bands; otherwise, clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Left breast soft tissue mass is noted for sonomamographic correlation

Abdomen:

- The liver is enlarged in size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- IUD is seen in place.
- Small left adnexal cyst is seen measuring about 2.5 cm likely functional.

OPINION:

- *Essentially normal CT study of the chest.*
- *Hepatomegaly.*
- *Left breast soft tissue mass for sonomamographic correlation*
- *Small left adnexal cyst likely functional.*

DR. Ibrahim Elsehawy, M.Sc, FEBR

Dr. m.gomaa, md



Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

Histopathology report

Report Number: 515

Female :	النوع	فائق حسني شوقي	اسم المريض :
القاهرة :	العنوان	36 Y	السن :
15/09/2020 13:12 :	تاريخ استلام العينة		تاريخ أخذ العينة :
17/09/2020 13:15 :	تاريخ التقرير	مركز صحة المرأة	مركز التحليل :
		مركز صحة المرأة	عنابة :

Primary sample :

breast core biopsy

comment :

Gross examination :

3 cores of greyish white tissue (T.I)

Microscopic examination :

section examined revealed fibrocollagenous tissue infiltrated by malignant growth displaying the morphology of infiltrating duct carcinoma with massive inflammatory cells infiltration

Referral Lab :

Comment :

Diagnosis :

BREAST CORES: THE PICTURE IS COMPATIBLE WITH INFILTRATING DUCT CARCINOMA, GII

Pathologist:

Dr. Jehan Aziz

Lab Director: د. نورا ناصر